

I. LAPORAN KEJADIAN

1	Pembuat Kronologi	Ns. Wisnu aji Nugroho, S.Kep
2	Nama Pasien	Tn. Bhakti Rahjaya
3	Unit Kerja yang terlibat	IGD
4	Tanggal Kejadian	6/07/2026

II. KRONOLOGIS KEJADIAN (dijelaskan secara detail hari dan jam kejadian)

Tanggal	Jam	Kronologi	Bukti
6/07/2026	02.36	Pasien datang dengan keluhan Nyeri dada, Nyeri dada dirasa sejak 30 menit SMRS, keluhan dirasakan muncul tiba", nyeri terutama dibagian kiri namun tidak menjalar, keluhan disertai sesak sejak hari ini, batuk disangkal, demam -, mual muntah -, badan lemas, nafsu makan menurun, BAB BAK dbn, sebelumnya rutin cuci darah di surabaya hari selasa jumat RPD: HT +, DM +, CKD on HD + Riwayat Penggunaan Obat : "Obat:Amlodipin; Reaksi:Bengkak Dengan TTV : GCS : 15(Composmentis) : (E4V5M6) Tekanan Darah : 240/116 Nadi : 97 Respiration Rate : 21 Suhu : 36,3°C SpO2 : 98% (Room Air) Kemudian Perawat triase mengarahkan keluarga untuk melakukan pendaftaran sambil menunggu dokter IGD untuk pemeriksaan lanjut.	
		Pasien sudah didaftarkan	



	Setelah dilakukan triase kemudian perawat triase melaporkan ke dr. Dicky bahwa ada pasien baru dengan keluhan diatas, kemudian Dokter dicky melakukan pemeriksaan dan anamnesa. *Pemeriksaan Fisik* *Kepala :* a/i/c/d -/-/-/- P.KGB (-) *Thorax :* C/s1/s2 single m (-) g (-) P/ves D/S rhonki -/- wh -/- -/- -/- -/- -/- *Abdomen :* Soefl, BU (+) Normal NT -/-/- -/-/- -/-/- hepar lien ttb *Ekstremitas :* AHKM +/-, CRT<2s oedem -/- *Lain-lain :* - *Diagnosis* Utama : Obs Dyspnea susp CKD Sekunder: "Obs Chest Pain" *Pemeriksaan Penunjang* Laboratorium : Darah Lengkap, Kreatinin Darah, ECG, Gula Darah Sesaat, Ureum , Elektrolit Radiologi : FOTO THORAX AP *Rencana Terapi dan Tindakan* O2 nc 4 lpm Inf NS 7 tpm Inj Santagesic 1 gr Inj Ranitidin 50 mg	
	perawat memberikan terapi kepada pasien sesuai dengan advice dr. IGD	
	Hasil lab	

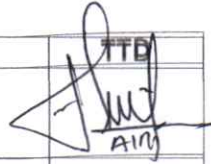
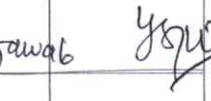
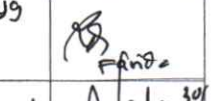
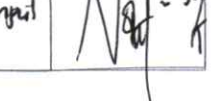
6/07/2026	04.32	Setelah lab jadi pasien di konsulkan ke dr ardhany spkgh	
	07.00	Jam 7 dokter ardhany masih belum memberikan advc tambahan, Lalu yang sift malam ,mengoperkan kepada sift pagi untuk tn Bhakti masih belum ada balasan Setelah itu gak lama kemudian dr rdhany membalas dan memberikan terapi	
		dr. IGD mengkonsulkan ke DPJP (dr. Adityo Rahmat,Sp.PD) kemudian mendapatkan advis : O2 Diit rp rg, pantang buah/sayue, minum 600 cc/24 jam Nicardipin 1.0 mcg/kgbb/menit Plug Iv furosemide 3x20 mv Iv santagesic 3x1 Iv ca glukonas 3x1 Po isdn 3x5 mg Po ketoacid 1x1 Po telmisartan 80 mg 1-0-0 Po asam folat 2x1 Nebule ventasal tiap 6 jam Prc 1 labu premed dipenhidramin Lab skrining hd Advc dr ardhany semuanya i inputkan dan i masukan ke pasien , untuk perihal lab permintaan skrining hd , perawatan Wisnu salah input yang harusnya HBsAg di inputkan hba1c	

	Setelah itu pasien di naikan oleh perawat ayu ke kamar ,sebelum lab jadi , Dan ternyata waktu operan di ruangan perawatan Sinta menanyakan terkait inputan skrining hd ada yang salah ,bukanya HBsAg tetapi hba1c	
--	--	--

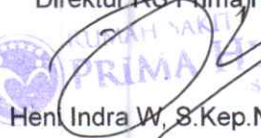
III. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Keteledoran perawat terkait advc
2. Kurangnya pengecekan ulang

IV. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	TTD
*Kepala Keuangan RS Ruang IGD	- lebih teliti lagi jika melakukan penginputan.	
*Kabid Pelayanan Medik	- Kerja harus lebih - proses sesuai ketentuan - tanggung jawab yang bersangkutan.	
*Kabid Keperawatan		
*Kabid Penunjang Medik	- lebih teliti , kerugian bertanggung staf yg bersangkutan	
*SDM RS	Lakukan double check sebelum finalisasi untuk input billing. Mohon lebih berhati-hati	

Menyetujui
Direktur RS Prima Husada


Heni Indra W, S.Kep.Ns.M.Kep

Pembuat Kronologi



Ns. Wisnu Aji Nugroho, S.Kep

1. lebih teliti dalam bekerja , lakukan double cek saat input

Catatan Direktur : 2. Proses sesuai ketentuan